DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 09 DE 12

Mindfulness e tolerância ao mal-estar

Como a formulação de caso organiza metas de vida e avaliação de risco, e como mindfulness e as habilidades de tolerância ao mal-estar ajudam o paciente a atravessar uma crise sem piorar a situação.

ENCONTRO DE SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 2026
CONDUZIDO POR ANDRESSA JULIANA, COM JÚLIO GONÇALVES

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

— A formulação de caso em DBT reúne as metas de vida do paciente, a avaliação de risco e o registro das intervenções usadas — ela fundamenta o compromisso com o tratamento e organiza a resposta à crise.

— Mindfulness em DBT é observar eventos internos e externos sem julgamento e sem tentar mudá-los de imediato — a função é aumentar o intervalo entre o impulso e a ação.

— A mente sábia é a síntese dialética entre a mente racional e a mente emocional, mais um saber intuitivo — não a média aritmética das outras duas.

— Tolerância ao mal-estar é uma estratégia de curto prazo para atravessar a crise sem piorar a situação — não substitui o trabalho de regulação emocional de médio prazo.

— Mindfulness pede cautela em quadros com pensamento mágico — psicose, episódios maníacos, transtorno de personalidade esquizotípica — onde pode ser iatrogênico.

01 A formulação de caso: metas de vida

A formulação completa em DBT é extensa e, no dia a dia clínico, opcional — mas alguns elementos centrais precisam ser conhecidos para orientar a condução do caso: o modelo biossocial, os dilemas dialéticos e, sobretudo, as metas de vida do paciente.

As metas de vida são aquilo que motiva a pessoa a seguir em tratamento independentemente das dificuldades do caminho — e precisam ser descritas de forma estritamente concreta: não "ter uma família feliz", mas o que, especificamente, caracterizaria essa família para aquela pessoa. Essas metas sustentam o compromisso terapêutico e são o que se recupera nos momentos de desesperança, quando a motivação para continuar esmorece (Linehan, 1993).

02 Avaliação de risco e registro

A formulação também inclui a avaliação do risco de suicídio e autolesão — a instrutora recomendou o uso de um instrumento estruturado para essa avaliação, além do registro sistemático de todas as intervenções realizadas. Documentar não é burocracia: é o que permite reconstruir, depois, o raciocínio clínico que levou a cada decisão.

[nota de método — o nome do instrumento de avaliação de risco citado em aula não ficou claro na transcrição automática; precisa ser confirmado antes da publicação.]

03 Análise em cadeia: o lembrete rápido

A análise em cadeia — já trabalhada em detalhe na Aula 06 — volta aqui como parte da formulação: ela deve se concentrar em um comportamento-problema específico, ligado à hierarquia de alvos do caso. A recomendação prática é conduzir mais de uma análise em cadeia para o mesmo padrão, comparando-as para identificar elos comuns que se repetem — são esses elos recorrentes, e não um episódio isolado, que orientam a intervenção.

04 Materiais de apoio e adaptações da DBT

Os materiais de apoio e os manuais de habilidades estruturam o trabalho tanto do paciente quanto do terapeuta: o manual do paciente reúne fichas de aplicação e tarefas, e o manual do terapeuta foi atualizado em sua segunda edição, publicada pela Artmed (Linehan, 2015/2018).

Além do protocolo padrão — pensado primariamente para treinamento em grupo —, existem adaptações para populações específicas: para pais e filhos, e um protocolo voltado ao transtorno de estresse pós-traumático que integra validação do trauma ao tratamento da desregulação emocional, descrito por Harned, Korslund e Linehan (2014).

05 Treinar como paciente: a recomendação da instrutora

Os pacientes não precisam aprender todas as habilidades do protocolo — apenas aquelas que a formulação de caso aponta como relevantes para aquele padrão específico. Para o terapeuta, a recomendação foi passar, ele mesmo, por um treinamento de habilidades na posição de paciente — experimentar o processo em primeira pessoa muda a qualidade de como a habilidade é depois ensinada em sessão.

06 Mindfulness na DBT: definição e função

Mindfulness, na definição de Marsha Linehan, é a prática de observar eventos internos e externos sem julgamento e sem tentativa imediata de mudança. Em pacientes impulsivos, sua função específica é aumentar o intervalo de tempo entre o impulso e a ação (Linehan, 1993, 2015).

O conceito foi adaptado de treinamentos contemplativos e atravessa todos os módulos do tratamento — não é uma habilidade isolada, mas a base sobre a qual as outras se apoiam. Há evidência consistente de melhora na atenção e redução da impulsividade associada à prática.

07 Práticas formais e informais

A prática formal exige tempo reservado e o foco numa âncora específica (a respiração, por exemplo); a prática informal se integra à rotina do dia — lavar a louça, caminhar — sem exigir um momento separado. Para pacientes com resistência ou franca fobia à meditação, a prática informal é o ponto de entrada recomendado.

COMEÇAR PEQUENO EVITA A DESISTÊNCIA

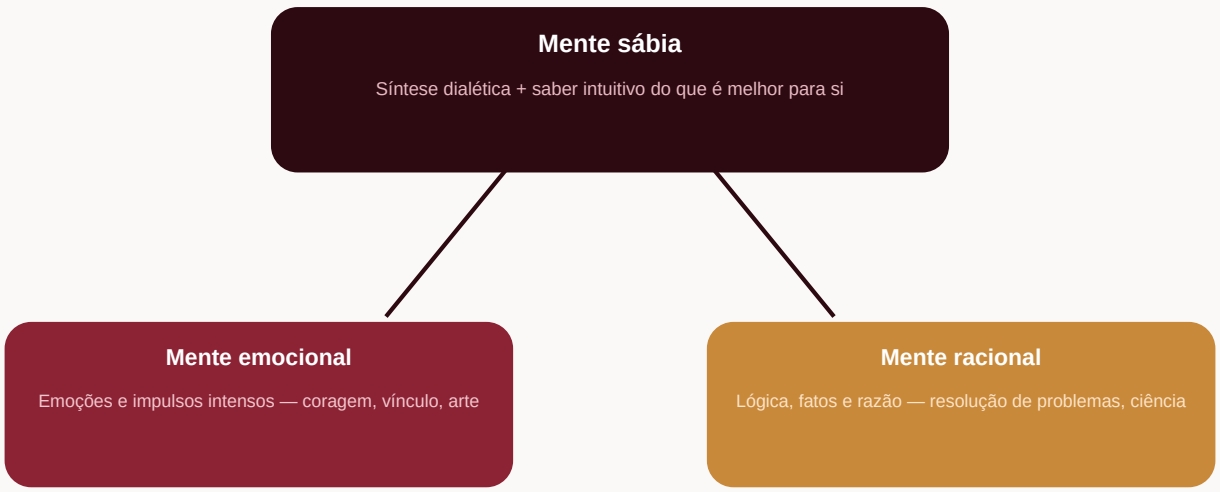
A meditação formal deve ser introduzida de forma gradual — trinta segundos, um minuto — especialmente com pacientes hiperativos ou com TDAH, para quem um tempo de prática longo de início tende a gerar mais angústia do que benefício.

08 Mente emocional, mente racional e mente sábia

A mente emocional é comandada por emoções e impulsos intensos — é também a fonte de atos de coragem, de vínculo profundo e de expressão artística. A mente racional é comandada pela lógica, pelos fatos e pela razão — essencial para resolver problemas e para o raciocínio científico. Nenhuma das duas é, em si, um defeito: cada uma tem seu contexto de uso.

A mente sábia é a síntese dialética entre as duas, somada a um saber intuitivo — a pessoa sabe o que é melhor para si, ainda que não consiga justificar esse saber com os termos da mente racional. Acessá-la é difícil e exige sintonização: muitos pacientes confundem um estado emocional intenso com a mente sábia, quando na verdade é o oposto dela.

FIGURA 1 · A MENTE SÁBIA COMO SÍNTESE



A mente sábia não é a média das outras duas — é uma terceira forma de saber, que inclui a intuição.

09 Práticas para acessar a mente sábia

Entre os exercícios sugeridos: a visualização de uma lasca de pedra descendo lentamente até o fundo de um lago (recomendada como ponto de partida, por ser mais acessível a quem está começando), a técnica de inspirar a mente e expirar a sabedoria, e o questionamento repetido a cada respiração, deixando espaço para que uma resposta interna apareça.

10 Observar: a primeira habilidade do "o quê"

Observar é prestar atenção a eventos internos ou externos sem tentar alterá-los. É uma habilidade fundamental para que o paciente supere a esquiva e a fobia emocional — grande parte do sofrimento vem menos da emoção em si do que da tentativa desesperada de não sentir.

As práticas iniciais são sensoriais e concretas: focar em um objeto físico, numa textura, num cheiro, ou na própria respiração — um jeito de construir, pouco a pouco, a capacidade de tolerar uma experiência desconfortável sem fugir dela.

11 Descrever e participar

Descrever é verbalizar estritamente o que foi observado, separando pensamento de fato objetivo — "ele não respondeu minha mensagem" é diferente de "ele está com raiva de mim". É uma habilidade central para pacientes que distorcem informações ou interpretam a realidade sem observá-la primeiro, e pode ser treinada descrevendo imagens ou o próprio conteúdo mental.

Participar é o engajamento total numa atividade, sem julgamento e sem a autoconsciência que separa quem age de quem observa a si mesmo agindo — um estado próximo do que a psicologia descreve como flow. É a meta final do mindfulness, especialmente relevante para pacientes com timidez acentuada ou medo intenso de errar. Entre as práticas sugeridas: escrever de trás para frente, desenhar a própria mão, jogos de palavras em grupo.

12 As habilidades do "como": não julgar, uma coisa por vez, ser efetivo

A postura não julgadora significa abster-se de rótulos como certo/errado, bom/ruim — descrever fatos, consequências e sentimentos, sem interpretar a intenção de quem agiu. É particularmente útil em momentos extremos de idealização ou desvalorização, e precisa ser construída por meio de prática — abandonar o julgamento automático é um treino, não uma decisão única.

Fazer uma coisa de cada vez é concentrar a mente numa única tarefa: o multitarefismo em geral consome mais tempo, não menos, e faz com que momentos importantes passem despercebidos. Alternar a atenção entre tarefas é possível e às vezes necessário — o ponto não é a rigidez, é agir de forma consciente em vez de por impulso.

Ser efetivo é mirar a meta desejada lidando com o mundo como ele de fato é, inclusive jogando conforme as regras do contexto quando isso for necessário para alcançar o resultado. Muitos pacientes confundem validação com a necessidade de provar que estão certos — o que costuma ser inefetivo justamente nos relacionamentos que mais importam.

13 Esclarecimento: validação não é concordância

Pacientes com histórico de invalidação costumam exigir que os outros concordem com seus pensamentos para se sentirem validados — e isso gera conflitos que não precisariam existir. O ponto central é que as pessoas ao redor têm o direito de pensar e sentir de forma diferente; validar a experiência de alguém não exige concordar com sua conclusão.

14 Tolerância ao mal-estar: o que é e para que serve

Tolerar o mal-estar é a capacidade de perceber o ambiente e experimentar estados emocionais sem tentar alterá-los ou controlá-los à força. É uma estratégia deliberadamente de curto prazo: serve para atravessar uma crise sem piorar a situação, não para resolver o problema de fundo — essa parte é trabalho de regulação emocional, em outro momento, fora da crise aguda.

> **Progresso mínimo também é progresso**
> Uma paciente que inicialmente não conseguia se concentrar em nada durante a crise, e passou a conseguir assistir a uma série (ainda que parando para chorar com frequência), representa um avanço real — o objetivo nessa fase não é eliminar o sofrimento, é capacitar a pessoa a atravessar cada crise um pouco melhor que a anterior.

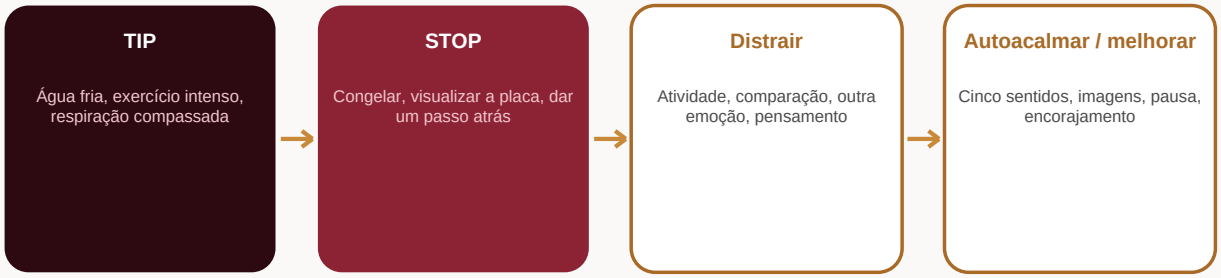
15 TIP: mudar a fisiologia na crise aguda

As estratégias TIP atuam diretamente sobre a fisiologia do corpo, em momentos de intensidade emocional muito alta ou de dissociação — quando nenhuma estratégia puramente cognitiva ainda é acessível. Incluem água fria no rosto (que ativa o reflexo de mergulho em temperaturas próximas de 10°C, associado à retenção da respiração), exercício físico intenso por cerca de 20 minutos, respiração compassada (inspirar em cinco segundos, expirar em sete) e relaxamento muscular progressivo (Linehan, 2015).

16 STOP: interromper o impulso

A habilidade STOP serve para pausar uma ação que está sendo guiada por impulso, no calor da crise. A sequência orientada em aula: congelar fisicamente, sem mover um músculo; visualizar uma placa de pare; dar um passo físico para trás; e só então analisar a situação com mindfulness, antes de agir.

FIGURA 2 · FERRAMENTAS DE TOLERÂNCIA, EM SEQUÊNCIA



TIP muda a fisiologia; STOP interrompe o impulso; distração, autoacalmar-se e melhorar o momento sustentam a travessia até a crise baixar.

17 Pistas ambientais, distração e as estratégias finais

Para que o paciente lembre de usar as habilidades justamente no momento em que a mente emocional está mais ativada — e menos acessível à razão —, pistas ambientais ajudam: planos de crise resumidos, com desenhos simples, fixados em locais estratégicos como o espelho do banheiro ou a caixa de remédios, e mensagens fixadas no topo de uma conversa de WhatsApp por tempo limitado.

Distração reduz temporariamente o contato com um estímulo emocional intenso quando o problema não pode ser resolvido de imediato — ocupar-se com outra tarefa, contribuir com algo, comparar com uma situação pior, induzir outra emoção por filme ou música, ou distrair-se por pensamento (contar, cantar mentalmente). Esse repertório precisa ser planejado fora dos momentos de crise, não inventado durante ela.

Autoacalmar-se usa os cinco sentidos — visão, audição, olfato, paladar, tato — para reduzir a vulnerabilidade à mente emocional; melhorar o momento usa imagens relaxantes, breves pausas e encorajamento próprio para atravessar o pico sem piorar a situação. A análise de prós e contras de um comportamento impulsivo específico completa o repertório, e deve constar do próprio plano de crise.

18 Nota clínica: cautela com mindfulness em pensamento mágico

Mindfulness não é uma ferramenta neutra em todos os quadros. Em transtornos que envolvem pensamento mágico — esquizofrenia, episódios maníacos do transtorno bipolar tipos 1 e 2, transtorno de personalidade

esquizotípica — a prática pode ser iatrogênica, intensificando em vez de regular o estado do paciente. O contraste foi ilustrado com a eficácia da DBT justamente nos quadros de alta desregulação emocional, onde esse risco não se aplica da mesma forma.

[fonte a confirmar — a cautela com mindfulness em quadros psicóticos e maníacos é consistente com a literatura sobre intervenções contemplativas nesses contextos, mas a observação em aula partiu de um caso clínico relatado, e não de uma referência específica citada nominalmente.]

19 Referências

Harned, M. S., Korslund, K. E., & Linehan, M. M. (2014). A pilot randomized controlled trial of Dialectical Behavior Therapy with and without the Dialectical Behavior Therapy Prolonged Exposure protocol for suicidal and self-injuring women with PTSD and borderline personality disorder. *Behaviour Research and Therapy, 55*, 7–17.

Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. New York: Guilford Press.

Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2nd ed.). New York: Guilford Press. [ed. bras.: *Treinamento de habilidades em DBT*, 2ª ed., Porto Alegre: Artmed.]

NOTA DE MÉTODO

Este resumo foi destilado a partir da transcrição automática da aula — repetições e marcas da fala oral foram removidas, o conteúdo foi reorganizado em ordem didática, e exemplos clínicos foram mantidos sem identificadores. Duas observações ficaram marcadas como [fonte a confirmar] ou [nota de método] por não ter sido possível verificá-las com segurança a partir da transcrição automática; revisar antes da publicação.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- [ ] Revisei as metas de vida de um paciente — de forma concreta e descritiva, não em frases genéricas.
- [ ] Pratiquei eu mesmo(a) ao menos um exercício de mente sábia antes de ensiná-lo a um paciente.
- [ ] Usei observar, descrever ou participar em sessão, nomeando a habilidade para o paciente.
- [ ] Montei (ou revisei) um plano de crise com pistas ambientais concretas — não só uma lista de passos.
- [ ] Perguntei, antes de indicar mindfulness, se o quadro do paciente pede cautela (pensamento mágico, psicose, mania).

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. **Um paciente diz que "mente sábia" é só um jeito bonito de chamar o que ele já sentia antes — intensamente, sem pensar. Como diferenciar isso de verdade?**

02. **Durante uma crise aguda, um paciente te liga dizendo que não consegue nem lembrar o que fazer. As pistas ambientais do plano de crise não ajudaram nessa hora. O que revisar primeiro?**

03. **Uma paciente com episódio maníaco em curso pede para praticar mindfulness porque "ajudou muito" numa crise depressiva anterior. Que cuidado a literatura e a aula pedem aqui?**